Il mondo attuale ha uno strano rapporto con l'educazione. Da un lato, sembra moltiplicare le modalità attraverso cui raggiunge ogni persona inducendo, più o meno consapevolmente, stili di comportamento, pratiche di esperienza e abitudini di vita, esibendo traguardi cui arrivare, obiettivi da raggiungere, modelli da imitare. L'educazione è ovunque: nella sua informalità e liquidità è diffusa in ogni luogo che ciascuno di noi frequenta. Ce ne rendiamo conto, appunto, dagli effetti che provoca: condivisibili o deprecabili che siano.

D'altro lato, l'educazione, che avviene nelle scuole e nei servizi educativi, riabilitativi o sociali, sembra essere in qualche modo data per scontata: perché è esperienza obbligatoria, perché è necessaria risposta a bisogni ricorrenti o emergenti. In questo scenario, l'educazione rischia di essere svuotata di senso. Di fronte a ciò, si afferma la necessità di aver cura dell'esperienza che essa rappresenta.

Il testo, partendo da una riflessione sul rapporto tra cura ed educazione, si interroga su cosa possa significare oggi *fare educazione*, su cosa comporti averne cura senza prescindere dalla sua complessità e materialità. Lo fa guardando al lavoro educativo, alle competenze e alle strategie che lo sostengono. Suggerisce prospettive di riflessione, nell'intento di rappresentare, per chi a questo lavoro si accosta o per chi lo svolge ormai da tempo, appunti per la propria pratica.

Cristina Palmieri è ricercatrice di Pedagogia generale e sociale presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi di Milano Bicocca, dove insegna Consulenza nel disagio educativo: teorie e pratiche e Didattica. Tra le sue pubblicazioni ricordiamo *La cura educativa. Riflessioni ed esperienze tra le pieghe dell'educare* (FrancoAngeli, 2000) e *Non di sola relazione. Per una cura del processo educativo* (Mimesis, 2008, con Giorgio Prada). Con Giorgio Prada, ha curato *La diagnosi educativa. La questione della conoscenza del soggetto nelle pratiche pedagogiche* (FrancoAngeli, 2005).

FrancoAngeli
La passione per le conoscenze

ISBN 978-88-568-3826-8

565.1.1 C. PALMIERI UN'ESPERIENZA DI CUI AVER CURA...

Cristina Palmieri

UN'ESPERIENZA DI CUI AVER CURA...

Appunti pedagogici sul fare educazione

Pratiche pedagogiche

Cen
Stuc

Copyright © 2011 by FrancoAngeli s.r.l., Milano, Italy

Ristampa

0 1 2 3 4 5 6

Anno

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

L'opera, comprese tutte le sue parti, è tutelata dalla legge sui diritti d'autore.
Sono vietate e sanzionate (se non espressamente autorizzate) la riproduzione in ogni modo e forma (comprese le fotocopie, la scansione, la memorizzazione elettronica) e la comunicazione (ivi inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo: la distribuzione, l'adattamento, la traduzione e la rielaborazione, anche a mezzo di canali digitali interattivi e con qualsiasi modalità attualmente nota od in futuro sviluppata).

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale, possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da AIDRO (www.aidro.org, *e-mail* segreteria@aidro.org).

Stampa: Tipomonza, via Merano 18, Milano.

quanto "portatore di bisogni", di cui si tende a enfatizzare, quindi, la dimensione del limite.

In fondo, però, abbiamo cura degli altri, dei loro corpi, perché *sono* portatori di bisogno e il bisogno spesso è inteso come quello «stato di minorità» che legittima l'intervento di cura (Barone, 2005). Paradossalmente, la cura, che comunemente si ritiene richieda empatia, proprio per questo può non contemplarla, o fingere di farlo. Anche quando sia *educativa*.

Per comprendere cosa significhi aver cura del corpo nelle situazioni educative, occorre allora fare i conti con la dimensione del bisogno. Ma cos'è, più precisamente, il bisogno? E come lo possiamo intendere e considerare nel lavoro educativo?

2.2 Bisogno, cura, educazione

A livello di senso comune, quando parliamo di cura, di cura degli altri, la connessione con la dimensione del bisogno è evidente. Ci occupiamo, abbiamo cura di qualcuno perché costui o costei *hanno bisogno*: hanno bisogno della nostra presenza, delle nostre cure, delle nostre premure perché bambini, perché malati, perché anziani. E noi prestiamo le nostre cure in quanto genitori, figli, parenti, piuttosto che come professionisti (insegnanti, maestri, educatori, ausiliari; infermieri e medici, operatori e operatrici sanitari). E, attraverso le nostre cure, diamo luogo a esperienze che sono anche educative, esperienze che, in maniera più o meno evidente e riconosciuta, lasciano (o possono lasciare) un segno nell'esistenza delle persone di cui ci occupiamo.

In ogni caso la nostra cura o il nostro intervento educativo sono richiesti, giustificati, legittimati da uno stato di bisogno che sembra coincidere con uno *stato di minorità*, di impedimento, di insufficiente autonomia, temporanea o cronica. In questa rappresentazione, la cura e l'educazione sono necessitate da uno stato di mancanza, e si trasformano in pratiche necessarie anch'esse non solo per la vita, ma addirittura per la sopravvivenza delle persone. Ciò che le connota, allora, è il comporsi di azioni riparative, compensative, normalizzanti, terapeutiche. Si interviene laddove qualcosa non va, laddove ci sono carenze, stati, acuti ma non solo, di bisogno, appunto. E interviene *chi sa* o perché ha esperienza della vita, o perché detentore di saperi particolari (pedagogici o medici, per esempio), o perché maggiormente in grado di mediare tra le richieste del mondo di tutti e la situazione di alcuni.

In questa rappresentazione, che sembra molto diffusa, forse la più diffusa nella nostra cultura, tanto da arrivare a denominarla «cultura terapeutica» (Rovatti, 2006), il bisogno ha dunque un ruolo centrale. Il bisogno giustifica la cura, richiede l'intervento educativo. Li legittima. E legittima il ruolo di chi cura, il potere che costui o costei esercitano su coloro che sono i destinatari di cure e interventi educativi: proprio perché non autonomi non possono che "dire sì" alle cure offerte per "il loro bene"; si fatica a contemplare la possibilità di un loro rifiuto, di una reazione che non vada nella direzione che chi cura pensa sia quella giusta (Canevaro, Chieregatti, 1999).

Se stressiamo questo concetto, la connessione tra cura, intervento educativo e bisogno si può proprio individuare nel *potere*: nell'esercizio di un potere che implica la possibilità di mettere l'altro in condizione di fare autonomamente, piuttosto che di far fare ciò che chi cura pensa sia giusto, o ancora di estromettere l'altro dal proprio poter fare per fare al suo posto. Sappiamo tutti che nella cura e in educazione il potere esiste: cura ed educazione *sono* esercizio di potere, anche se non ci piace parlarne e allora preferiamo parlare, per esempio, di accoglienza. Ma accogliere significa comunque esercitare un potere. Un potere che deriva a chi cura o educa dal fatto che qualcun altro si trovi in una qualunque situazione di bisogno, e che, di fatto, *dispone* in una relazione, un un'esperienza.

2.2.1 C'è bisogno e bisogno

Occorre dunque approfondire cosa significhi "bisogno", e farlo da un punto di vista critico, che interroghi alcune concezioni ovvie del bisogno.

Nella seconda metà del 1900, Maslow rappresentava i bisogni come in una piramide (Maslow, 2010).

I bisogni sono rappresentati in scala: dai bisogni *primari*, fisiologici, la cui soddisfazione garantisce la sopravvivenza di qualunque essere umano, ai bisogni *secondari* ma non meno importanti, la cui soddisfazione consente l'autorealizzazione individuale. Guardando lo schema, si ha l'impressione che, se non si risponde ai bisogni primari, è difficile che i secondari non solo vengano colmati, ma addirittura si manifestino. Di primo acchito, tendiamo a leggere questa piramide in scala, in un'ottica progressiva. Siamo abituati a pensare che *sia* così. Ma l'esperienza del bisogno si articola proprio così? La relazione tra bisogni primari e secondari si snoda sempre seguendo un'unica direzione di senso, una dinamica in qualche modo progressiva? E ancora, quale peso hanno, nella cura e in educazione, i bisogni fisiologici? Quale ruolo e funzione siamo abituati a dare a questi bisogni, nella vita come nella professione (di cura)?

Andrea Canevaro ci viene in aiuto:

> Maslow non intese questa costruzione in un senso geometrico e neanche stratificato, ma la rappresentò secondo uno schema che ha tutte le caratteristiche dello schema che va scomposto, riorganizzato, per capire che la realtà non è uno schema (Canevaro, 2002, p. 6).

Proviamo allora a scomporre questo schema, a partire da alcune riflessioni.

Secondo Riccardo Massa, il bisogno, come categoria concettuale e operativa, *descrive* e *prescrive*: nel modo in cui il bisogno si manifesta e nel modo in cui si risponde a esso è in gioco *il buon funzionamento dell'organismo* (Massa, 2003). Comunemente, il bisogno, soprattutto quello primario (di nutrirci, di lavarci, di dormire), essendo fisiologico – naturale, nell'ordine della normalità –, non solo *descrive* come funzioniamo, in maniera in un certo senso *oggettiva*, ma in qualche modo indica anche ciò che occorre fare: se un bisogno fisiologico è nutrirsi, occorre nutrire, e in modo adeguato, sempre; se un bisogno fisiologico è dormire un certo numero di ore per notte, è necessario fare di tutto perché i ritmi e i tempi di sonno/veglia siano rispettati. Il bisogno dunque *descrive oggettivamente*, dopo un'attenta osservazione, come funzioniamo e quindi *prescrive* come si *deve* funzionare. Il punto è che descrive come funziona l'*organismo*: descrive (e quindi prescrive) le *funzioni* di un corpo visto innanzitutto come *organismo*. Non che sia sbagliato: occorre però chiedersi *come* siamo abituati a rappresentarci ciò che chiamiamo "bisogno", quale logica implicita, quali modelli di comprensione e quali rappresentazioni del corpo contribuiscano ad attribuire un certo significato al bisogno.

Ora facciamo un esperimento. Ancoriamo il bisogno al funzionamento dell'organismo (all'interno di una rappresentazione oggettivante del corpo), e proviamo a leggere la piramide di Maslow. La sensazione è che, se non la percorriamo superficialmente, la presunta linearità che la figura evoca si perde e si è indotti ad andare oltre l'immagine di bisogno da cui si è partiti. Ciò che è in gioco non sembra essere la mera risposta ad un bisogno inteso come mancanza:

> La respirazione è fatta di un ritmo, di un'alternanza di pieni e di vuoti dei nostri polmoni, e un neonato, bambina o bambino, respira e ha quindi un ritmo, un'alternanza di pieni e di vuoti. E poi si alimenta, e quando deve succhiare il latte deve combinare la respirazione e l'alimentazione. In questa combinazione deve imparare a fare qualcosa che noi chiamiamo *controllo*: deve controllare la propria respirazione in rapporto al suo bisogno di alimentazione, al suo appetito. L'alimentazione è determinata da un vuoto e, con il cibo, il vuoto sparisce, si colma un bisogno. Rimane, però, il gusto dell'alimentazione che potrebbe andare oltre il bisogno e arrivare a creare una situazione di saturazione. Occorre che quel bambino, quella bambina, *abbia una capacità di essere controllato da un adulto* (la figura materna) e poi pian piano *assuma il controllo dell'operazione* dell'alimentazione e non mangi troppo, altrimenti farà una piccola indigestione (Canevaro, 2002, p. 6)[4].

Nel trattamento dei bisogni, è in gioco allora la possibilità di *apprendere a controllare*, a governare le situazioni che essi creano. Occorrono allora gesti, tempi e quindi parole altrui per esercitare e acquisire il controllo del proprio funzionamento: questo, forse, vale non solo per i bisogni primari, collocati sul primo gradino della piramide di Maslow, ma anche per altri tipi di bisogni, per esempio per il bisogno di sicurezza, piuttosto che di appartenenza e riconoscimento sociale. La risposta a un bisogno fisiologico non è semplicemente fisiologica, non può essere ricondotta a una reazione necessaria, quasi automatica: ogni risposta a un qualsiasi bisogno mobilita dimensioni altre, indissolubilmente legate a quella corporea, come l'immaginazione e il pensiero; immette in un mondo di significati, in un mondo culturale e sollecita la creazione di significati, l'accesso al pensiero condiviso, in altre parole un'appartenenza a una visione del mondo, a una modalità di interpretare l'esistenza e ciò che accade nel corpo; ovvero, a una cultura.

I bisogni fisiologici sono indissolubilmente legati alle situazioni corporee e contingenti in cui sono vissuti; si possono riconoscere come univer-

[4] Il corsivo è dell'autrice.

sali (cioè come bisogni che tutti hanno) solo nella loro culturalizzazione, ovvero quando vengano decodificati e interpretati in base ad appartenenze culturali che segnano, definiscono, danno senso e significato al modo di esistere delle persone, e quindi ai bisogni stessi. L'appartenere (a una comunità, e quindi riconoscersi in determinate visioni del mondo) è anch'esso un bisogno esistenziale, e la constatazione che tutti i membri di una comunità hanno gli stessi bisogni (fisiologici) può suscitare l'idea di un'appartenenza. Anch'essa però è frutto di un lavoro di costruzione culturale:

> La base larga della Piramide di Maslow può permettere di far sentire tutti gli umani con un'appartenenza. È un elemento che non può rimanere, però, nella base; è qui che lo schema mostra i suoi limiti di schema. Deve salire e deve fare una visita alla punta della piramide, a quei bisogni culturali che sono di ciascuno di noi e sono diversi per ciascuno di noi; hanno come dotazione l'individualità. I bisogni fisiologici sono anche individuali e nello stesso tempo comuni. C'è bisogno di culturalizzare, termine che non è elegantissimo, i bisogni fisiologici, per capire che contengono la nostra appartenenza, o meglio per partire, per capire che ciascuno è parte di un'appartenenza molto ampia, quasi senza confini; ma bisogna fare un passaggio attraverso i bisogni culturali (ivi, p. 8).

Non esistono, dunque, bisogni fisiologici in sé: ma modalità di viverli, di dare loro significato, anche attraverso semplici gesti che li esprimono o che li accompagnano. Si tratta di significati *situati* all'interno di visioni del mondo, di culture differenti. E, in ogni caso, si tratta di modalità che la stessa complessità dell'esistenza sembra sempre confondere, intrecciare. Basti pensare al modo in cui quotidianamente facciamo esperienza dei nostri bisogni, a partire da quelli primari.

Se è vero che se non mangiamo (bisogno primario) facciamo fatica a sentirci "al sicuro" (bisogno secondario), e il nostro equilibrio e la nostra autostima vacillano o comunque subiscono qualche scossone, tuttavia sappiamo bene che queste azioni (mangiare, nel nostro esempio) non servono solo a "colmare dei buchi", a placare l'appetito quando abbiamo fame o all'esigenza di ricaricarci se siamo stanchi. Queste azioni hanno anche *altri significati*, che straripano nei territori dei cosiddetti *bisogni secondari*. Non si mangia solo per mangiare, ma anche per condividere con qualcuno ciò che ci nutre, per scambiare qualcosa; non si dorme solo per ricaricarsi ma anche per riposarsi, per sognare, per rielaborare quanto accade nella vita diurna; non ci si lava solo per essere puliti, ma anche per rendersi gradevoli, ai propri occhi e a quelli degli altri. Per ognuna di queste azioni, ogni gruppo sociale ha cercato ed elaborato un significato condiviso. Non è allora in gioco solo una questione di sopravvivenza, ma la questione del senso che, attraverso queste azioni, connesse a questi bisogni, un'esistenza impara a darsi. Dal punto di vista pedagogico, ciò significa che ognuno *si forma* attraverso la risposta soggettiva e sociale ai bisogni.

Entriamo, in questo modo, in un'altra visione del bisogno: non più solo necessità determinata da una mancanza, da un senso di vuoto, da uno stato di minorità; non più solo malessere da estinguere, buco da riempire, ma situazione che provoca reazioni e azioni a cui, come esseri umani, diamo immediatamente un significato, fosse anche quello detto prima, di dover essere svolte per risolvere una situazione di malessere. Si tratta di un significato che non nasce solo da noi, dalle necessità del nostro organismo, ma anche dall'ambiente relazionale e culturale in cui siamo cresciuti. Il fatto che l'esigenza di nutrirsi abbia dato luogo a interessantissime culture alimentari, segnando stili di vita differenti, in qualche modo, lo manifesta.

Dietro il bisogno ci può essere quindi l'organismo, ma ci può essere – come ben sa chi svolge un lavoro di cura, più o meno esplicitamente educativa – anche la *persona*, o meglio un soggetto che, essendo immediatamente in relazione con il mondo e con gli altri attraverso il suo corpo, sede dei suoi cosiddetti bisogni, dà forma a se stesso, costruisce la sua esistenza dando senso a ciò che sente, a ciò che fa e a ciò che pensa all'interno di un contesto (materiale e culturale) che gli fornisce modalità di comportamento, rappresentazioni di sé, dei suoi stessi bisogni, del suo corpo, di ciò che potrà diventare: dimensioni, elementi che toccherà sempre al soggetto metabolizzare, elaborare, scegliere.

In quest'ottica, il bisogno diventa altro: non solo mancanza, esigenza fisiologica da ascoltare per soddisfarla, ma *esperienza corporea* che avviene in un contesto relazionale, e che può acquistare significati differenti, esistenzialmente fondamentali proprio nel momento in cui il bisogno stesso è terreno di esperienza relazionale.

Non si tratta di un'esperienza eccezionale, ma di ciò che si realizza ogni volta che, per esempio, un genitore dà da mangiare al proprio figlio: non si tratta solo di colmare quel "buco nello stomaco" che fa piangere in maniera inconsolabile un neonato, ma anche di fare, insieme, l'esperienza del nutrirsi, che è esperienza relazionale e affettiva attraverso cui, inconsapevolmente, si trasmette un certo modo di sentire, vedere, pensare l'altro (più o meno autonomo, più o meno competente) e ciò che si sta compiendo insieme. Simbolicamente, si offrono infatti ai soggetti gli strumenti – di pensiero – per poter capire cosa stia succedendo quando provano quel senso di vuoto, e allora come possano agire, come possano farsi aiutare, ma soprattutto come possano cominciare a immaginarsi, a pensare, a dare si-

gnificato a ciò che sentono, e quindi a controllare quell'esperienza, cioè a diventare sempre un po' più padroni del proprio corpo, delle proprie sensazioni ed emozioni e soprattutto degli strumenti che consentono di affrontare quella stessa esperienza con minor disagio possibile, se non addirittura con piacere. In poche parole, la presenza del bisogno fa intravedere e può inaugurare uno *spazio di esperienza e di comunicazione* (corporea, paraverbale, verbale): spazio che crea quella cornice entro cui l'esperienza del bisogno diventa tollerabile, possibile, pensabile; al punto da poter, addirittura, essere affrontata e risolta da soli, senza l'aiuto di un adulto o di chi sa come fare. In questo modo, forse, si acquisisce quel controllo dei propri bisogni di cui parla Canevaro.

Così, inoltre, si restituisce spazio all'esperienza corporea più intima, fatta anche di sensazioni ed emozioni che stentano a trovare parole che le rappresentino, e, soprattutto, si rimette il corpo, nella sua materialità, al centro dell'esperienza educativa, intesa come quel processo attraverso cui ogni soggetto può cercare ed elaborare il senso della propria esperienza esistenziale che affonda le sue radici in ciò che il corpo prova (Barone, 2009, p. 99).

2.2.2 Aver cura dei bisogni

Se il bisogno racchiude in sé quanto abbiamo esposto, quali scenari si aprono, per le pratiche di cura che si danno nelle situazioni educative? Quali significati possono essere attribuiti alle azioni di cura educativa? E ancora, in che senso possono educare le pratiche di cura con cui si risponde a ciò che chiamiamo "bisogno"?

Da quanto detto, siamo di fronte a relazioni e pratiche certo sollecitate da urgenze o necessità, che tuttavia forse, oltre allo scopo di affrontare quelle emergenze, possono anche trasformarle in un'occasione di *comunicazione, di scambio, di ricerca di senso*. Dal punto di vista pedagogico, è in gioco la possibilità di utilizzare quello che accade, quello che si dà, nella vita di tutti i giorni, come terreno non solo di accoglienza, ma anche di *coltivazione* delle potenzialità delle persone: potenzialità che necessitano di essere immaginate, viste, pensate, restituite e quindi supportate da chi non si trova nella stessa situazione di chi ha bisogno, e quindi ha la possibilità di vedere *altro* e *oltre* la situazione contingente.

Non solo. Quando noi ci occupiamo di qualcuno che sentiamo essere in una situazione di bisogno, le nostre cure possono coltivare ciò che chiamiamo *desiderio*. Nel momento in cui ci occupiamo degli altri attraverso una serie di gesti che preparano la soddisfazione del bisogno istituendo delle ritualità, mettiamo in atto, come già accennato, quello nella letteratura psicopedagogica viene chiamato *maternage*: costruiamo insieme al soggetto una cornice fatta di gesti, di parole che non soddisfano immediatamente il bisogno ma, lasciandolo sentire, fanno nascere la capacità di desiderare, cioè di immaginare che ciò di cui si ha bisogno si possa concretizzare (Winnicott, 2002). In questo modo, il vissuto corporeo si trasfigura, nella sua concretezza, in immaginazione e desiderio[5]. All'interno di questa cornice, il bisogno, che nasce nell'esperienza corporea, può trasformarsi in comunicazione, in linguaggio (corporeo, paraverbale e non verbale, prima che verbale): espressione di una mancanza che può, già in sé, essere espressione di uno "stare" in essa e contemporaneamente capire come uscirne o come mitigarla; esperienza in cui può animarsi però anche una ricerca di senso.

Certo, in tutto ciò si dà comunque una situazione di potere da parte di chi educa o cura: potere che consiste nel disporre l'altro all'interno di un'esperienza, supportandolo nell'affrontarla, ovvero fornendogli quegli strumenti affettivi e cognitivi che gli consentiranno di fare da sé o almeno di chiedere aiuto, a modo suo. Il potere (educativo) si esercita proprio attraverso la predisposizione di *questi* strumenti, nella possibilità di trasformazione di *questa* esperienza.

Il peso della tradizione

La questione è che questo punto di vista sulla cura, sull'educazione e sul bisogno non è semplice da sostenere.

Si può presumere che lo sia in quelle situazioni che *naturalmente* sembrano aprirsi alla dimensione progettuale, che *naturalmente* sembrano porre a confronto con soggetti da cui ci si aspetta la manifestazione di desideri propri, apertamente diversi da quelli di chi se ne occupa, come avviene, talvolta, con i bambini, con gli/le adolescenti[6]. Ma la pratica del lavoro edu-

[5] Del resto, anche riprendendo la tradizione filosofica, il desiderio sembra essere strettamente imparentato con la condizione di bisogno. Secondo Natoli: «Nell'uomo il bisogno prende forma di "desiderio" (...) Gli uomini... soprattutto adattano a sé l'ambiente in cui vivono e "intenzionalmente" lo trasformano. Lo fanno certo per soddisfare i loro bisogni, ma un loro peculiare bisogno è quello di espandersi. Questa voglia di espandersi è il desiderio. Ora, come è noto, la natura del desiderio è doppia: in quanto spinta, voglia, è manifestazione di "potenza"; in quanto bisogno di qualcosa che non si ha, è costitutivamente "mancanza"» (Natoli, 2010, pp. 28-29).

[6] Sulla problematicità dell'espressione e della presenza di desideri autentici da parte degli adolescenti, si veda Barone (2009a).

cativo ci dice che una tale dinamica non si può dare per scontata, che nulla è *naturale*: lo stesso fatto di ritenere naturali gesti, espressioni, bisogni indica un'appartenenza culturale, abitudini apprese in contesti particolari.

Ci si chiede infatti cosa significhi aver cura della persona quando ci si trova a occuparsi di persone magari fortemente compromesse nelle loro funzioni corporee o mentali, piuttosto che di persone anziane, colpite magari da gravi patologie che sconvolgono le loro abitudini, i loro pensieri, i loro affetti. Forse in questi casi è molto più semplice, per chiunque, vedere *solo* il bisogno primario, il bisogno fisiologico, e agire *solo* in nome di quello. Può essere più agevole, laddove il limite è palese (o lo è una sua dimensione), lavorare solo sul suo contenimento, sull'estinzione delle urgenze che in esso nascono, per ristabilire una normalità almeno dal punto di vista dei bisogni primari e del funzionamento di un organismo, soprattutto laddove i canali di comunicazione con le persone di cui si ha cura non siano aperti, o immediati. Può essere più semplice non solo per una certa tradizione oggettivante, che la cultura medica attuale sta però cercando (faticosamente) di relativizzare e di superare (Zannini, 2008), ma anche perché vedere dietro quei limiti dei soggetti desideranti può essere molto faticoso dal punto di vista esistenziale, soprattutto all'interno di contesti di cura o riabilitazione costruiti per far fronte a quegli stessi limiti. Sappiamo bene quanta fatica la nostra cultura faccia e abbia fatto nel relazionarsi con esperienze quali la malattia, la morte, il dolore, la follia, e come abbia trovato nella possibilità di allontanare e quindi di studiare queste esperienze – come se fossero staccate dalla quotidianità, come se non riguardassero tutti e chiunque – un modo per avvicinarsi a loro, per trattarle, per concettualizzarle, per farci i conti (Foucault, 1963).

La tradizione della cura e dell'assistenza nella cultura occidentale mostra questa fatica. Come abbiamo accennato nel primo capitolo, c'è stata un'epoca (forse non del tutto estinta), nella storia della nostra cultura, in cui alcune persone, percepite come portatrici di limite e minorità, potevano essere curate solo se trasportate in strutture predisposte *ad hoc*, in luoghi "a parte". Lì, sottoposti a uno sguardo terapeutico, medico, apprestato per intervenire su ciò che era percepito come "guasto da risanare", quei corpi vissuti venivano oggettivati; l'oggettivazione è diventata così un modo, se non *il* modo, per rispondere ai bisogni, e a bisogni percepiti come *anormali*[7]. Sembra così essersi consolidata un'abitudine, di pensiero ma anche di azione: per curare occorre rendere gli altri "oggetti". E accanto a essa, si è strutturata un'altra convinzione, ovvero che la presenza del bisogno sia indizio di patologia. Chi ha bisogni in eccesso rispetto a quelli che la sua età anagrafica dice che dovrebbe presentare, chi non è in grado di occuparsi di se stesso in relazione al suo sviluppo ha qualcosa che non va. E quindi va curato, attraverso trattamenti adeguati.

Ci sono situazioni emblematiche, come quelle di disabilità, in cui alcuni bisogni permangono a vita, perché i soggetti non sono in grado di farvi fronte autonomamente; spesso, sono proprio quei bisogni, che non si possono estinguere, a essere patologizzati, o meglio a trasformare una condizione esistenziale in patologia, *tout court*. In questo senso, come si diceva precedentemente, l'unico modo per convivere con essi è contenerli: far sì che almeno non siano eccessivi. Allora occorre che contesti e persone si specializzino nella loro gestione: che facciano, come si tende a dire, una "buona", professionale, assistenza. Fermo restando che, dove si fa normalmente assistenza, può accadere che non ci si chieda quale situazione stia vivendo la persona, ma che si presti attenzione e si spenda energia perché quella situazione venga normalizzata, per limitarne gli eventuali danni. È in questo senso che i bisogni vengono avvertiti come limiti da contenere entro una cornice di accettabilità. Normalizzare, allora, significa riportare alla normalità, evitando possibili degenerazioni. Nella conduzione della quotidianità tutto deve rientrare nel buon funzionamento della gestione dell'istituto, della comunità, del centro diurno, tendendo a rimuovere il significato più profondo ed esistenziale del bisogno e del limite.

Tra «cura autentica» e «cura inautentica»

Eppure, la nostra esistenza si compie nel confronto con limiti e bisogni che, in maniera diversa, segnano ciascuno, nonostante la tendenza a rimuoverne la considerazione. Non basta studiare le situazioni o le persone che li evocano maggiormente, ponendo una distanza, come se non quei limiti e quei bisogni non appartenessero a tutti, e gestirli addomesticandoli. Non è facile, ma se ci interessa comprendere cosa facciamo quando ci occupiamo degli altri – bambini, anziani, malati, disabili – occorre chiederci come ci rapportiamo alla dimensione del bisogno, del desiderio, del limite, del potere. E quindi *come* curiamo.

È possibile, in tutto ciò, vedere all'opera quelle che Heidegger ci ha insegnato a riconoscere come pratiche di «cura inautentica», a cui abbiamo già accennato nel capitolo precedente (Heidegger, 1976a). Seguendo una certa tradizione culturale, le nostre cure tendono a corrispondere a un'azione di sostituzione dell'altro nella sua capacità di aver cura di sé, del pro-

[7] Per un approfondimento, si veda Foucault (1963, 1969, 2000, 2004).

prio mondo, delle proprie potenzialità. Chi cura, tende a «sostituirsi dominando»: quando toglie all'altro la possibilità di imparare ad avere cura di se stesso innesca una relazione di dipendenza, limitando le possibilità altrui di sperimentare e di sperimentarsi. Non solo: la sostituzione è subdola. Perché le cure possono essere assidue, impeccabili; le camere dei pazienti o degli ospiti profumare di pulito ma non è detto che tutto ciò sia «autentico», se per autentico intendiamo, con Heidegger, quella cura, intesa come preoccupazione, relazione, esperienza in grado di «anticipare» le possibilità esistenziali dell'altro, «liberandolo per la propria cura»; una cura che non si sostituisca in ciò che ognuno di noi ha di più prezioso, ovvero nella capacità di occuparci di noi stessi, di sentire i nostri bisogni, di dar loro dei nomi, di comunicarli, di chiedere aiuto, di affrontarli, da soli o con qualcuno; di sentire, e di esprimere, i propri desideri (Heidegger, 1976a).

Entrare nella prospettiva della «cura autentica» non implica illudere una persona anziana, disabile o in situazione di forte disagio, sulle sue possibilità, ma comporta comprendere insieme a lei quale senso stia assumendo quello che nel presente vive, sente, può fare o dire; a volte si tratta solo di aiutare a sentire, oppure, come nel caso di persone affette dal morbo di Alzheimer, di aiutare a ricordare per poi accettare che si possa subito dimenticare. Non si tratta di coltivare possibilità infinite, ma *la* possibilità di afferrare, sia solo per un attimo, come sia stata costruita la propria esistenza, continuando a darle senso. Non si tratta semplicemente di fare dei bilanci su come una persona abbia vissuto, a volte non ci sono le condizioni materiali o la disponibilità emotiva per fare ciò; si tratta invece di utilizzare i bisogni come possibili luoghi di senso, di comunicazione e quindi di apprendimento, ancora una volta, di qualcosa che riguarda sé. Giorno dopo giorno, nel quotidiano. Soprattutto quando ci si occupi di persone gravemente compromesse, ogni occasione può diventare esperienza in cui ricercare senso: si tratta di stare nella situazione concreta, nel qui e ora, creare spazi di lavoro e di tolleranza, predisporre spazi di comunicazione, di desiderio.

Il nostro aver cura, allora, ha a che fare con la possibilità di istituire delle situazioni in cui le persone ogni giorno possano scoprire chi poter essere proprio in quanto tali: bambini e bambine, persone disabili, anziane, senza fissa dimora, con i propri bisogni e limiti. È in questo senso che la cura a che fare con una continua oscillazione tra l'effettività – le condizioni in cui una persona si trova, frutto del suo passato e del suo ambiente – e la possibilità. La cura cade nell'inautenticità quando invece si arresta alla considerazione dell'effettività, quando non abita l'oscillazione tra effettività e possibilità.

Da un punto di vista operativo si comprende bene come tutto ciò non significhi rivoluzionare ciò che abitualmente accade nei luoghi educativi o di cura; non si tratta di imporre nuove pratiche o tecniche di cura e di educazione, sulla carta più efficienti. Il lavoro educativo che si svolge nella quotidianità rimane ed è centrale. Quello che però può cambiare è il modo di vedere e pensare la cura, i bisogni, e quindi le persone che curano e quelle che sono curate; quindi il modo di agire. In questo senso può essere presente, anche nelle situazioni assistenziali, un'attenzione pedagogica. Può modificarsi il modo di agire, nei tempi e negli spazi consentiti, attraverso la presenza di attenzioni altre, concentrate per esempio sull'uso di oggetti quotidiani non legati necessariamente ad esigenze riabilitative, didattiche o a incombenze di *routine*, ma sensati e familiari all'interno dell'esperienza vissuta che ogni singola persona porta con sé. Quello che può cambiare è il modo di pensare e quindi di vestire i ruoli di cura, le funzioni della cura, aprendo spazi laddove si danno, nella gestione dei bisogni, in vista della possibilità di esperienze, anche residuali, minime, tali da inseguire e magari riattivare desideri, e quindi soggettività forse sopite. Quello che si può cambiare è lo sguardo sul bisogno, sul disagio, sull'emergenza: non solo dentro i luoghi in cui cura ed educazione si danno, ma anche fuori da essi, laddove si producono le condizioni che danno origine a quei bisogni, quei disagi, quelle emergenze. E, sappiamo, modificare uno sguardo è già cominciare a modificare le pratiche di trattamento.